

CEFALEAS

Alba Gallego Gallego, Nuria Martínez Cao, Maria Cruz Pérez Panizo.

INTRODUCCIÓN

Detectar las cefaleas secundarias es lo más importante. La cefalea es un motivo frecuente de consulta médica y a pesar de que la mayoría son cefaleas primarias es de vital importancia detectar las cefaleas secundarias.

Cefaleas primarias

- Migraña
 - Migraña sin aura o migraña común
 - Migraña con aura o migraña clásica
 - Migraña con aura típica
 - Migraña con aura prolongada
 - Migraña familiar hemipléjica
 - Migraña basilar
 - Aura migrañosa sin cefalea
 - Migraña con aura de comienzo agudo
 - Migraña retiniana
 - Síndromes periódicos de la infancia
 - Migraña complicada
 - Status migrañoso
 - Infarto migrañoso
 - Trastornos migrañosos inclasificables
 - Otros síndromes
 - Migraña oftalmopléjica
 - Seudomigraña con pleocitosis
- Cefalea tensional o tipo tensión
 - Cefalea tensional episódica
 - Cefalea tensional crónica
- Cefalea en racimos (cluster) o cúmulos y otras cefaleas trigeminovegetativas
 - Cefalea en racimos
 - Cefalea en racimos con periodicidad indeterminada
 - Cefalea en racimos episódica
 - Cefalea en racimos crónica
 - Hemicránea paroxística
 - SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)
- Otras cefaleas primarias
 - Cefalea punzante idiopática
 - Cefalea por compresión externa
 - Cefalea por estímulos fríos
 - Cefalea benigna por la tos
 - Cefalea benigna por ejercicio físico
 - Cefalea benigna asociada a actividad sexual

Cefaleas secundarias

- Cefalea asociada a trauma craneal y/o cervical

- Cefalea traumática aguda
- Cefalea postraumática crónica
- Cefalea asociada con trastornos vasculares craneales y/o cervicales
- Cefalea asociada a trastornos intracraneales no vasculares ni infecciosos
- Cefalea asociada a sustancias o a su privación
- Cefalea asociada a infección
- Cefalea asociada a trastornos homeostáticos
- Cefalea o dolor facial asociados a trastornos en el cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales
- Cefalea atribuida a trastornos psiquiátricos
- Neuralgias craneales y dolor facial de origen central
- Otros tipos de cefalea, neuralgia craneal o dolor facial central

Temporalidad:

Súbita no recurrente: Hemorragia subaracnoidea, Ictus, disección arterial cervical.

Agudas de reciente comienzo: secundaria a infección intracraneal/trombosis de senos venosos o venas cerebrales/arteritis de la temporal/trastornos de hemostasia/ingesta o abstinencia de sustancias/hipotensión intracraneal/traumatismo craneoencefálico/trastornos oculares, ORL, ATM, alteraciones cervicales...

Agudas recurrentes: migraña (migraña común o sin aurea, migraña clásica o con aura), cefaleas trigémino-autonómicas: en racimos/hemicránea paroxística/SUNCT/SUNA, neuralgias: del trigémino/postherpética,

Agudas progresivas: síndrome de hipertensión intracraneal, si idiopática: pseudotumor cerebro*.

Crónicas diarias: migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea por abuso de medicamentos.

Migraña: más en mujeres y con antecedentes familiares. Instauración rápida y progresiva, persiste de 4 horas a 3 días. Desencadenantes: estrés (sobre todo cuando éste cesa), menstruación, cambios atmosféricos, chocolate, lácteos, bebidas alcohólicas, cafeína, fármacos, exceso o defecto de horas de sueño. El dolor se intensifica con el esfuerzo y el movimiento.

- **Sin aura:** la más frecuente, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada/grave, empeora con actividad física rutinaria, suele asociar náuseas/vómitos y foto/sonofobia. El examen físico, la exploración neurológica y pruebas complementarias son normales. La duración del cuadro varía desde 4 a 72 horas.
- **Con aura:** asociada a síntomas neurológicos (irritativos o deficitarios) originados en la corteza o en el tronco cerebral con desarrollo gradual (fenómeno de depresión cortical propagada), durante 5-20 minutos (menos de 60 minutos), aura más típica: la visual (escotomas centellantes, las teicopsias, las metamorfopsias y defectos hemianópsicos), puede haber síntomas hemisensoriales o disfasia, precede a la cefalea (intervalo inferior a 1 hora), pero no siempre y a veces a la vez; **status migrañoso:** dura más de 72 horas a pesar de tratamiento, puede haber intervalos sin cefalea inferiores a 4 horas (sin incluir las horas de sueño), suele asociarse al abuso prolongado de fármacos.

Cefalea tensional: se desencadena por el estrés o cansancio, puede o no presentar contractura cervical, es la más frecuente, no familiar, instauración insidiosa, de tipo opresivo (no pulsátil), leve a moderada y bilateral en el 90%, en la región frontotemporal, vértex o área occipitocervical,

describiéndola como “casco” o “cinta”, empeora durante el día, falta de sueño o estrés. El examen físico y neurológico es normal.

Cefalea en racimos: más en varones, poco frecuente. A la misma hora (primeras fases del sueño). Desencadenantes: tabaco, alcohol. Dolor unilateral episódico (racimos, cluster o ataques), muy intenso, no cambia de lado, centrado en región orbitaria o temporal con duración de 15 a 180 minutos y frecuencia variable (1 episodio cada 2 días, 8 al día, etc), desde semanas a meses; inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, edema palpebral, inquietud en hemicara ipsilateral.

Hemicránea paroxística: más en mujeres, unilateral, pulsátil, intensidad muy fuerte, en región periorbitaria, sien, frente o parte superior de la cara, duración de 3 a 30 minutos, desde un ataque a más de 40 al día. A diferencia del cluster, durante las crisis la paciente prefiere estar quieta (sentada, posición fetal); inyección conjuntival, lagrimeo, ptosis, edema pálpebral, rinorrea, congestión nasal.

SUNCT-cefalea unilateral neuralgiforme con reacción conjuntival/lagrimeo: más en hombres, 50 años de edad, dolor unilateral moderado-grave, rama oftálmica del trigémino (punzante, perforante, urente, lancinante, pulsátil), unos 50-100 episodios diarios de breve duración (5-240 segundos), zonas gatillo que pueden precipitarlo al tocar la cara o el cuero cabelludo, al hablar, comer, masticar, cepillarse los dientes, afeitarse o toser.

Neuralgia del trigémino: ataques que se desencadenan por estímulos cutáneos sobre boca o nariz (lavarse los dientes, afeitarse, masticar...), típico un período refractario breve en el que un nuevo estímulo no puede evocar otro ataque; unilateral, paroxístico, fulgurante, inicio y finales bruscos, muy corta duración (segundos a 2 minutos), territorio de una o más ramas del V par (segunda y tercera).

Arteritis de la temporal (de Horton): sospechar en todo paciente mayor de 55 años, con **clínica clásica** de dolor en zona del temporal, polimialgia reumática, claudicación mandibular, síntomas visuales (amaurosis fugaz, diplopía, pérdida o disminución de agudeza visual, alucinaciones), febrícula/fiebre, pérdida de peso, anemia. Al examen físico puede presentar dolor a la palpación sobre arteria temporal, tortuosa, con presencia, ausencia o disminución del pulso y dura. Analíticamente se objetiva la proteína C reactiva (PCR) y la velocidad de sedimentación globular (VSG superiores a 100 mm en la primera hora) elevadas, anemia generalmente normocrómica y normocítica. Mejoría clínica franca con la administración de corticoides, que deben de administrar cuanto antes para evitar la complicaciones como la ceguera. Su diagnóstico se confirma con la biopsia de arteria temporal.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Una anamnesis dirigida a diferenciar las cefaleas primarias de las secundarias. Representa un elemento esencial para el diagnóstico de las cefaleas debido a que en la mayoría de las veces la exploración física y los exámenes complementarios son normales. Nuestra anamnesis será dirigida a obtener información sobre:

- **Antecedentes personales**, familiares (en la migraña hay aproximadamente 60% de antecedentes familiares) y medicación habitual (anticonceptivos orales, tipos de medicamentos y analgésicos que toma).

- **Edad de inicio.** Insistir en la edad de comienzo (niñez, juventud, madurez, ancianidad).
- **Tipo de cefalea** (cefaleas crónicas o recurrentes, agudas o recientes progresivas).
- **Tiempo de evolución** actual.
- **Características de la cefalea.**
 - Instauración: brusca/súbita o progresiva/gradual.
 - Localización del dolor: frontal, occipital en vértex, en banda, orbitaria, focal, holocraneal, hemicraneal, en caso de recurrencias valorar la alternancia.
 - Irradiación.
 - Tipo de dolor: pulsátil/urente/sordo/punzante.
 - Intensidad del dolor: Leve, moderada o intensa. Preguntar si el dolor es incapacitante en las actividades de la vida diaria, despierta por la noche.
 - Predominio horario: matutina, vespertina, nocturna, hora fija.
 - Cefaleas de predominio nocturno:
 - cefaleas paroxísticas:
 - cefalea tipo Horton (en racimos o cúmulos).
 - cefalea hemicraneal paroxística.
 - cefalea hípica (rara).
 - cefaleas no paroxísticas:
 - cefalea “de rebote” (por privación de fármacos).
 - hipertensión intracraneal,
 - arteritis de células gigantes,
 - hipercarbia,
 - apneas obstructivas del sueño.
 - Duración y frecuencia: Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años
 - Factores que modifican el dolor (precipitan, agravan o alivian): ejercicio físico, coito, tos, posiciones de la cabeza, alcohol, menstruación, anticonceptivos, etc.
- **Síntomas asociados:**
 - **Neurológicos:** alteraciones visuales, sensitivas, trastorno del lenguaje, pérdida de fuerza, síntomas irritativos, alteraciones del comportamiento, escotomas, hemianopsia, diplopía, inestabilidad. Cuando estos síntomas duren más de 1 hora obligan a descartar la presencia de una enfermedad vascular cerebral.
 - **No neurológicos:** náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, ansiedad, depresión, mareo, rinorrea, enrojecimiento ocular, mialgias, claudicación mandibular, fiebre.
- **Factores que modifican** precipitan o alivian la cefalea.

Exploración física

Siempre constantes vitales: tensión arterial, Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura. SatO2 y Glucemia.

El examen físico comprenderá:

- **Exploración general** incluyendo los senos frontales y maxilares, articulaciones temporomandibulares, arterias temporo-occipitales y músculos pericraneales, valorar el estado psicológico del paciente dada la posible relación con la etiología de la cefalea.
- **Exploración neurológica** completa y sistemática incluyendo raquis cervical.
- **Realizar fondo de ojo** con el fin de descartar papiledema.

Pruebas complementarias

Según la sospecha clínica que presente y presencia de **síntomas o signos de alarma**:

- Comienzo después de los 50 años.
- Instauración brusca de cefalea intensa (primer episodio) en estallido.
- Intensidad progresiva en su evolución.
- De reciente comienzo en pacientes con cáncer, coagulópatas o anticoagulados, inmunodeprimidos (VIH, corticoterapia crónica).
- Cefalea intensa desencadenada por esfuerzos, actividad sexual, tos o Valsalva o maniobras que aumenten la presión intracraneal, o que cede en decúbito (hipotensión intracraneal idiopática).
- Cambio llamativo de personalidad o deterioro cognitivo.
- Historia reciente de bacteriemia o infección de cabeza o cuello (absceso cerebral).
- Datos de enfermedad sistémica.
- Embarazo (preeclampsia) o postparto (trombosis seno venoso).
- Cefalea acompañada de datos de infección, convulsiones, alteración del nivel de conciencia, meningismo, papiledema o síntomas o signos focales.
- Cefalea que se propaga a occipitonucal y entre los hombros (irritación meníngea por infección o hemorragia subaracnoidea).
- Cefalea con alteraciones visuales (glaucoma, arteritis de células gigantes, hipertensión intracraneal idiopática, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible)
- Cambio en las características de una cefalea crónica o de una migraña,
- Exploración neurológica anormal.
- Exploración física anormal: ptosis, hipertensión arterial, datos de sepsis, , purpura o petequias de nueva aparición, soplo cervical (disección arterial).

En cefaleas con criterios de alarma y/o sospecha de cefaleas secundarias a enfermedades orgánicas intracraneales se solicitará:

- **Analítica sanguínea.**
 - Hemograma.
 - Coagulación.
 - Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa con **VSG o PCR** en mayores de 50 años (descartar arteritis de la temporal).
 - Sistemático de orina: hematuria y proteinuria en encefalopatía hipertensiva.
- **TAC craneal:** se realizará TAC Craneal si datos o sospecha de signos de alarma, antes de realizar la punción lumbar.
- **Punción lumbar:** ante sospecha de meningitis o meningoencefalitis, hemorragia subaracnoidea con TC craneal normal (se realizará diferida 6-8h tras inicio del dolor), hipertensión intracraneal con TC normal: HTIC idiopática.
- **RM craneal:** si se sospecha de trombosis de senos venosos con TC craneal normal, lesión de fosa posterior, seno cavernoso o silla turca, delimitación de obstrucción si hidrocefalia, sospecha de hipopresión licuoral.*

En cefaleas primarias con exploración neurológica normal, sin síntomas de alarma, no estarían indicadas.

TRATAMIENTO

Fundamentalmente el tratamiento será etiológico y posterior tratar el dolor.

Migraña

Medidas generales como reposo absoluto en cama, ambiente oscuro y sin ruidos.

Leve-moderada: asociar AINES + antieméticos (metoclopramida o clorpromazina o proclorperazina) + ansiolíticos (diazepam o lorazepam).

- Paracetamol 1g/8h vía oral / IV. o
- Dexketoprofeno 25mg/8h vía oral o ampollas con 50mg 1 cada 8-12h IM / IV. o
- Metamizol magnésico 575mg capsulas 1 cada 6horas vía oral o 1 ampolla con 2gr IV/IM cada 8h. o
- Naproxeno 550mg/12h vía oral o Ibuprofeno 600mg/8h vía oral.
- Metoclopramida (primperan) 10mg/8h vía oral, IM / IV. o
- Clorpromazina 7,5mg IV. o
- Proclorperazina 5 a 10mg IV
- Diazepam (Valium ampollas 10mg, comprimidos 5 y 10 mg) 5-10 mg cada vía oral/ IV cada 8h o
- Lorazepam (Orfidal 1mg) 1 mg vía oral cada 12h.

Moderada-grave: de inicio triptanes si no mejoría agregar: AINES + antieméticos + ansiolíticos.

- **Triptanes** (no como criterio diagnóstico diferencial ni en la fase de aura):
 - Sumatriptán: Imigran Neo comprimidos 50mg, Imigran nebulizador nasal de 10 y 20mg, Imigran jeringas precargadas de 6mg (6 mg subcutaneo o 20mg intranasal o 50-100mg vía oral) o
 - Zolmitriptán: Zomig 2,5mg comprimidos, Zomig nebulizador nasal de 5mg, Zomig Flas bucodispersables de 2,5 y 5mg (5mg intranasal o 2.5mg oral o sublingual, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, no sobrepasar 10mg/24h) o
 - Rizatriptán: Maxalt comprimidos 10mg, Maxalt Max liofilizados orales 10 mg (10mg oral o sublingual, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo de 20mg/día) o
 - Almotriptán: Almogran comprimidos 12,5mg (12.5 mg vía oral, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo 25mg/día) o
 - Eletriptán: Relpax comprimidos de 20 y 40mg (40mg vía oral, se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor, hasta un máximo de 80mg/día) o
 - Frovatriptán: Forvey o Perlic comprimidos de 2,5mg (2.5mg vía oral se puede repetir a las 2 horas si no sede el dolor) o
 - Naratriptán: Naramig comprimidos de 2,5mg (2,5 - 5mg vía oral)

Grave y status migrañoso: sumatriptán 6mg sc y/o analgesia/AINE u opiáceos, antieméticos, sedación con diazepam 10mg/12h iv o clorpromazina 25mg/8h im, y en caso de ausencia de respuesta: corticoides (dexametasona 8mg iv, metilprednisolona 60-120 mg iv), suelen precisar ingreso hospitalario;

Migraña en el embarazo: paracetamol-codeína oral o rectal, si no cede: meperidina iv, AINEs y AAS sólo en tratamientos cortos y en el tercer trimestre, triptanes y ergotamínicos: contraindicados.

Tratamiento preventivo: más de 4 ataques/mes, tratamiento agudo contraindicado, ineficaz o intolerable por efectos adversos, auras muy frecuentes o invalidantes o afectación calidad de vida:

ácido valproico, topiramato, zonisamida, amitriptilina, propranolol, antagonistas del calcio, antagonistas de la serotonina, AINE, Toxina botulínica.

Cefalea tensional

Paracetamol y/o AINEs, amitriptilina 25-75 mg/día oral en dosis única nocturna.

Cefalea en racimos (crisis)

Oxígeno con mascarilla reservorio al 100% (7-12 L/minuto durante 15 minutos), sumatriptán 6 mg sc (límite de edad: 65 años), o intranasal. Tratamiento profiláctico: prednisona 60 mg/día en pauta descendente cada 3-4 días hasta retirar y verapamilo de 240 a 960 mg/día simultáneamente con la prednisona (riesgo de alargamiento PR con dosis altas); carbonato de litio 600-900 mg/día si fracasa lo anterior.

Hemicránea paroxística

Indometacina 25 mg/8h vía oral.

SUNCT-cefalea unilateral neuralgiforme con reacción conjuntival/lagrimeo

Lamotrigina 100-200 mg/día • Gabapentina^{**}, ^{**} Carbamazepina • Topiramato

Neuralgia del trigémino

Carbamazepina: dosis inicial de 100mg/12h oral, subir cada 3 días hasta 800mg/día en 3 dosis, máximo: 1200mg/día u oxcarbamazepina 150 mg/12h. Se pueden asociar: baclofeno 5mg/8h oral^{**}, ^{**} Gabapentina 900-3600mg/día en casos resistentes o pregabalina 75-300mg/12h^{**}. Radiofrecuencia del ganglio de Gasser.^{**}

Arteritis de la temporal (arteritis de Horton)

- Prednisona (1 mg/kg/día) 60mg al día o
- Metilprednisolona (urbason) 1 mg/kg/día oral / intramuscular / intravenoso.

Criterios de ingreso

Cefalea de instauración súbita sugestiva de hemorragia subaracnoidea, Síntomas o hallazgos que sugieran un proceso orgánico cerebral, Estatus migrañoso, Infarto migrañoso, Migraña con aura típica, Cefaleas resistentes al tratamiento, Cefaleas acompañada de problemas psiquiátricos o médicos importantes.



Interpretación Líquido Cefalorraquídeo En Caso De Punción Lumbar

- Si leucocitos aumentados, no hay hematíes o hay pocos: probable infección que se deberá tratar con antibióticos y/o antivírico.
- Si presión de apertura normal con muchos hematíes en el primer tubo y pocos en el tercero, sin xantocromía: probable punción traumática: observación o ingreso para reevaluación si persiste la sospecha clínica.
- Si menos de 5 leucocitos, no hay hematíes, con glucosa y proteínas normales: si los déficits se resolvieron manejar como migraña aguda
- Hematíes en primer y tercer tubo ó hay xantocromía: probable hemorragia subaracnoidea

BIBLIOGRAFÍA

- Guía rápida de cefaleas. Consenso entre Atención Primaria y Neurología. Heras Pérez JA, Comité ad Hoc del grupo de Estudio de cefaleas de la SAN, SEMERGEN y SEMFYC. Granada 2012.
- Tratamiento de las cefaleas. Estrategias terapéuticas en Medicina de Urgencias. Roig Osca MA, 4ª Ed. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
- Guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. Extremadura 2015. Casado Naranjo I.
- Guía de buena práctica clínica en migraña y otras cefaleas. Atención Primaria de calidad. Toquero de la Torre F, Zarco Rodríguez J. 2003.
- Evaluation of the adult with headache in the emergency department. Cutrer FM. Uptodate 2013.
- Evaluation of the adult with nontraumatic headache in the emergency department. Cutrer FM, Wippold II FJ, Edlow JA. Uptodate 2018.
- Cefaleas y algias craneofaciales. Neurología. 2013. 5ª Ed. Zarranz Imirizaldu JJ.
- Harrison Principios de medicina interna. 2 vols. 18ª ed. México , D.F: Mc Graw Hill; 2012.